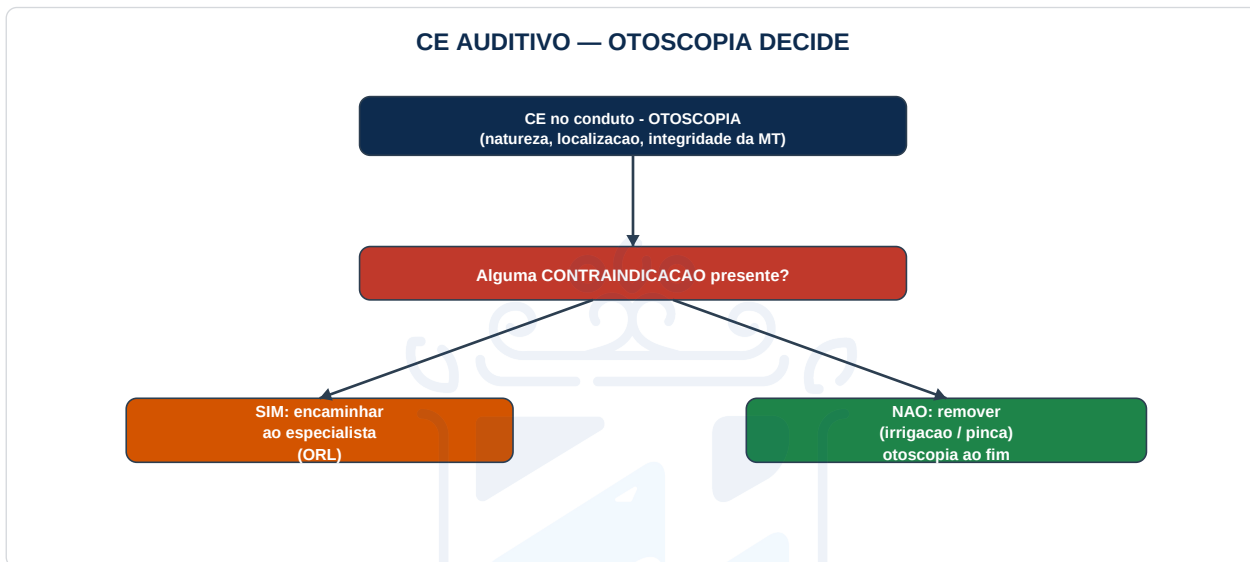


CORPO ESTRANHO NO CONDUTO AUDITIVO

FLUXOGRAMA — REMOVER OU ENCAMINHAR?



AVALIAÇÃO INICIAL

OTOSCOPIA SEMPRE

- Realizar otoscopia: identificar a natureza e a localização do corpo estranho
- Verificar a integridade da membrana timpânica e sinais de infecção secundária
- A técnica de remoção depende das características do corpo estranho
- Em crianças, examinar também outros orifícios (suspeita de CE em narina, etc.)

CONTRAINDICAÇÕES — ENCAMINHAR AO ESPECIALISTA

NÃO TENTAR NO PS SE

- Ausência de otoscópio na unidade ou de materiais adequados para a remoção
- Perfuração da MT ou impossibilidade de visualizar a MT; histórico de cirurgia otológica; otorragia
- Objetos PONTIAGUDOS ou de natureza corrosiva; presença de LARVAS no meato
- Otite associada ao quadro
- BATERIAS: NÃO retirar por irrigação (risco de liberar conteúdo cáustico) — remoção urgente especializada

REMOÇÃO POR IRRIGAÇÃO — MATERIAIS

Rx PREPARO

Campo/toalha + otoscópio + cuba rim + luva de procedimento
Seringa de 20 ou 60 mL
Scalp calibroso (> 19) cortado com ~2 cm (parte da cânula, sem agulha)
Água aquecida em temperatura MORNA (evitar reflexo vestibular por água fria/quente)
Não usar irrigação para baterias e objetos vegetais que incham

REMOÇÃO POR IRRIGAÇÃO — TÉCNICA

Rx PASSO A PASSO

1. Explicar o procedimento e sanar dúvidas; 2. Identificar o CE com o otoscópio
3. Aspirar o soro morno com a seringa e conectar ao scalp cortado
4. Posicionar campo no ombro, abaixando o ouvido a ser tratado
5. Introduzir o scalp com a concavidade para frente — evitar jato laminar direto sobre a MT
6. Instilar água de forma contínua e firme; repetir até a saída do CE
7. Se não sair: pinça fina OU encaminhar ao especialista; 8. Otoscopia ao final

QUANDO INTERROMPER / CUIDADOS

SEGURANÇA

- Interromper se: dor, desistência do paciente, ou insucesso após várias tentativas
- Objetos impactados no meato ou muito próximos da MT: mais seguros com otomicroscopia/videotoscopia (especialista)
- Insetos vivos: instilar lidocaína/óleo mineral para imobilizar ANTES de remover (reduz movimento e dor)
- Após qualquer tentativa, reexaminar a MT (excluir trauma/perfuração iatrogênica)
- Documentar a otoscopia final

CHECKLIST

ANTES E DEPOIS

- ☐ Otoscopia inicial: natureza/localização do CE, MT íntegra, sem infecção
- ☐ Excluídas contraindicações (perfuração, bateria, corrosivo, pontiagudo, larvas, otite, otorragia)
- ☐ Irrigação com água morna e técnica correta (sem jato sobre a MT)
- ☐ Otoscopia final documentada após a remoção
- ☐ Encaminhar ao ORL se falha, CE impactado/próximo à MT, bateria ou contraindicação

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ORL

- Corpo estranho em conduto auditivo ____ (orelha D/E), natureza: ____ (inseto/semente/bateria/objeto).
- Otoscopia: localização ____; MT íntegra: sim/não; infecção: sim/não; otorragia: sim/não.
- Tentativa de remoção no PS: irrigação/pinça — resultado: ____.
- Encaminhamento ao ORL por: contraindicação / falha / CE impactado-próximo à MT / bateria.

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Criança com bateria (pilha botão) no conduto auditivo. Qual a conduta correta?

- A) Remover por irrigação abundante
- B) NÃO irrigar; encaminhar para remoção urgente por especialista (risco de lesão cáustica)
- C) Aguardar a bateria sair sozinha
- D) Instilar água oxigenada
- E) Cauterizar o conduto

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é uma contraindicação à remoção de corpo estranho auditivo por irrigação no PS?

- A) Objeto inerte e arredondado
- B) Perfuração da membrana timpânica (ou objeto corrosivo/pontiagudo, larvas, otorragia)
- C) Boa visualização da membrana timpânica
- D) Paciente colaborativo
- E) Disponibilidade de otoscópio

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Por que se deve usar água em temperatura morna na irrigação do conduto auditivo?

- A) Para dissolver o corpo estranho
- B) Para evitar estímulo vestibular (vertigem/náusea) causado por água fria ou muito quente
- C) Para esterilizar o conduto
- D) Para anestesiá-la a membrana timpânica
- E) Para acelerar a cauterização

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Diante de um inseto vivo no conduto auditivo, qual medida facilita a remoção?

- A) Irrigar imediatamente com força
- B) Instilar lidocaína/óleo mineral para imobilizar o inseto antes da remoção
- C) Introduzir uma pinça pontiaguda às cegas
- D) Aspirar com sucção de alta pressão sem visualização
- E) Cauterizar o inseto

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Após a tentativa de remoção do corpo estranho, qual passo é indispensável?

- A) Liberar imediatamente sem reexame
- B) Realizar nova otoscopia para avaliar a integridade da membrana timpânica e o sucesso da remoção
- C) Prescrever antibiótico sistêmico de rotina
- D) Tamponar o conduto
- E) Aplicar calor local

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Baterias (pilhas botão) NÃO devem ser removidas por irrigação (a umidade libera conteúdo cáustico e gera necrose); exigem remoção urgente por especialista. É uma contraindicação explícita à irrigação.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Contraindicam a irrigação no PS: perfuração/impossibilidade de ver a MT, objetos corrosivos/pontiadudos, larvas, otite associada, otorragia, cirurgia otológica prévia e falta de material/otoscópio.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A água deve estar morna (próxima à temperatura corporal) para evitar a estimulação vestibular (prova calórica) que água fria ou quente provoca, causando vertigem, náuseas e desconforto.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Insetos vivos devem ser imobilizados/mortos antes da remoção, instilando lidocaína ou óleo mineral, o que reduz o movimento, a dor e o risco de lesão durante a retirada.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Após qualquer tentativa de remoção, repete-se a otoscopia para confirmar a retirada e avaliar a integridade da membrana timpânica, excluindo trauma/perfuração iatrogênica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico